

PLAN DE INTERVENCIÓN DE ATENCIÓN TEMPRANA INICIAL (PIAT)

El PIAT es un programa de atención global e individualizado, que recoge las características de cada menor y de su entorno, una valoración exhaustiva del desarrollo del mismo y los objetivos planteados en la intervención. En él se recogen las aportaciones tanto de los diversos profesionales del Servicio que intervienen en el proceso como de la familia, lo cual les permitirá descubrir sus propios recursos y, a la vez, reforzar la relación con su hija/o, aspecto muy importante para su evolución madurativa y afectiva. Se actualiza de forma frecuente en función de las necesidades y la evolución del menor y su familia.

INFORMACIÓN DIAGNÓSTICA Y MÉDICA :

DIAGNÓSTICO FUNCIONAL O.D.A.T. (Organización Diagnóstica de Atención Temprana):

4.g.g. Disfasia (TEDL) o (TPDL).

Diagnóstico Principal del CAIT : 4.k. Trastorno del desarrollo del lenguaje (TEDL).

ANTECEDENTES PERSONALES :

Segundo hijo de la pareja. Embarazo natural, controlado y bien tolerado. La madre presenta trombofilia en tratamiento con heparina durante la gestación. Parto a término en la semana 39 mediante cesárea programada por presentación de nalgas. Apgar 9/10. Peso 3.200 g, talla 50 cm y perímetro craneal 35 cm. No precisó reanimación. OEA y EIM normales. Lactancia artificial. Ingreso a los 47 días de vida en UCI por bronquiolitis moderada con necesidad de VMNI. Sin alergias ni patologías crónicas conocidas. No intervenciones ni tratamientos farmacológicos actuales.

ANTECEDENTES FAMILIARES:

Hermano de 9 años con desarrollo típico. No consanguinidad. No se refieren antecedentes familiares relevantes de trastornos del neurodesarrollo o del lenguaje.

OTROS DATOS DE SALUD DE INTERÉS :

Centro de salud de referencia: Gines.
En seguimiento por ORL y pediatría, sin hallazgos patológicos.
Sin otras derivaciones médicas activas.

DATOS DE ESCOLARIZACIÓN :

Centro Escolar: CEIP NUESTRA SEÑORA DE BELEN

Curso: 2º ciclo E. Infantil 3 años.

Acude contento y se encuentra bien integrado, participando en actividades colectivas.

ASPECTOS BIOPSICOSOCIALES :

ESTADO FÍSICO GENERAL:

Buen estado de salud. Desarrollo somático y proporciones corporales adecuadas. Presenta mordida abierta anterior, probablemente asociada al uso prolongado de chupete. Se desplaza de forma autónoma con buen patrón de marcha. Sin alteraciones significativas en la coordinación motora gruesa ni en las destrezas manipulativas.

ASPECTOS EMOCIONALES DEL NIÑO/A:

Alejandro es un niño alegre, tranquilo y colaborador durante las sesiones. Acepta compartir el juego con el adulto, responde a su nombre y mantiene contacto ocular. Demanda atención mediante gestos y muestra buena disposición al aprendizaje. Su temperamento es equilibrado, con buena regulación emocional y adecuada respuesta a las normas.

ASPECTOS EMOCIONALES DE LOS CUIDADORES PRINCIPALES:

Los padres se muestran muy implicados y receptivos con el proceso terapéutico. Han comprendido la importancia de la intervención temprana y mantienen buena adherencia y comunicación con los profesionales. Presentan estilo educativo democrático y afectivo, favoreciendo la autonomía progresiva del niño.

CONSIDERACIONES DEL ENTORNO FAMILIAR:

Alejandro reside en el domicilio familiar en Gines junto a su madre Desiree González Ojeda (42 años, técnica de enfermería), su padre Alejandro Tercero Gil (44 años, empleado de banca) y su hermano David (9 años, con desarrollo típico). Padres convivientes, entorno socioeconómico estable y red de apoyo extensa.

CONDUCTA:

En el ámbito familiar, Alejandro muestra buena conducta y capacidad para seguir órdenes. Presenta gestos instrumentales (señala, muestra, pide ayuda) y participa activamente en las actividades de la vida diaria, colaborando en el vestido, al poner la mesa o recoger juguetes. No se observan conductas disruptivas ni signos de alarma conductual.

En el entorno escolar, mantiene una relación adecuada con sus iguales, participa en el juego y muestra buena adaptación social.

SOCIABILIDAD:

Sonríe con facilidad, busca la interacción y tolera la separación de sus figuras de apego.

RED DE APOYO PROFESIONAL:

Recibe atención por el CAIT Neurointegra (Bormujos), con 1 sesión semanal de logopedia centradas en la estimulación del lenguaje comprensivo y expresivo.

No acude a otros servicios externos.

Sin intervención activa de servicios sociales.

No tiene reconocido grado de discapacidad ni dependencia.

EXPLORACIÓN MEDIANTE PRUEBAS ESTANDARIZADAS

PRUEBAS Y RESULTADOS:

Se administra Inventario de Desarrollo Battelle el día 27/10/25 con los siguientes resultados:

Área	Puntuación Directa	Percentil	Edad Equivalente
Personal/Social	95	1	30 meses
Adaptativa	70	12	35 meses
Motora Gruesa	64	64	45 meses
Motora Fina	33	5	29 meses
Motora General	97	15	33 meses
Comunicación Receptiva	22	8	32–33 meses
Comunicación Expresiva	19	1	20–21 meses
Comunicación General	41	1	24 meses
Cognitiva	42	16	36 meses
Total	345	3	32 meses

Perfil general: desarrollo global dentro de la normalidad salvo área comunicativa, con un desfase significativo en lenguaje expresivo y leve en comprensión.

MCHAT-R/F (14/05/2025): riesgo bajo para la presencia de un trastorno social y comunicativo.

EXPLORACIÓN CUALITATIVA DEL DESARROLLO ACTUAL

DESARROLLO MOTOR: Marcha independiente con buen equilibrio. Coordinación motora gruesa y fina adecuadas para la edad. Manipulación eficaz, aunque se observa agarre inmaduro en tareas de precisión.

DESARROLLO COGNITIVO: Atiende y comprende consignas simples. Mantiene la atención durante la actividad y demuestra buena memoria de trabajo visual. Presenta iniciativa en el juego y flexibilidad cognitiva. No se observan conductas repetitivas ni estereotipadas.

DESARROLLO COMUNICATIVO: Muestra intención comunicativa activa. Comprende órdenes sencillas y contextuales. Emite algunas palabras (vocabulario en aumento en las últimas semanas) y varias onomatopeyas, además de sonidos guturales y nasales. Utiliza gestos declarativos y protoimperativos. Lenguaje expresivo limitado con buen componente comprensivo.

DESARROLLO ADAPTATIVO: Participa en tareas de autonomía básicas: se viste y desviste parcialmente, recoge juguetes, ayuda a poner la mesa. Presenta buena disposición para colaborar. Sueño adecuado. Dificultades leves en transición a alimentos sólidos, con selectividad alimentaria parcial (prefiere pan, caramelos masticables, evita frutas y verduras).

PREOCUPACIONES ACTUALES DE LA FAMILIA

La familia manifiesta preocupación por el desarrollo del lenguaje expresivo, especialmente por la escasez de vocabulario y la lentitud en la aparición de nuevas palabras. Desean recibir pautas claras para estimular el habla en casa y favorecer la comunicación funcional.

OBJETIVOS FUNCIONALES

OBJETIVOS ACTUALES

NIÑO:

- Favorecer la imitación gestual y vocal.
- Aumentar la comprensión y expresión verbal mediante palabras funcionales.
- Estimular el uso de gestos comunicativos (señalar, mostrar, pedir).
- Potenciar la atención conjunta.
- Favorecer la construcción de oraciones simples de dos elementos.
- Consolidar rutinas de autonomía personal básicas.

FAMILIA:

- Orientar y dar respuesta a las necesidades de información planteadas.
- Reforzar estrategias de comunicación natural en el hogar.
- Ajustar expectativas respecto al ritmo de adquisición del lenguaje.
- Apoyar y reforzar conductas de implicación en el programa terapéutico.

- Coordinar los objetivos a trabajar con el niño en los distintos entornos (familia y escuela).

ENTORNO:

- Favorecer la coordinación entre familia, centro educativo y CAIT.
- Asegurar la coherencia de estrategias comunicativas en todos los contextos.

PROFESIONALES DEL PROCESO TERAPÉUTICO:

Los siguientes profesionales se encuentran participado de forma activa en el proceso terapéutico del/la menor:

Profesional de referencia: ANDREA PANEPINTO. LOGOPEDA

SESIONES PAUTADAS:

Tipo	UMAT/MES
Niño/a	4
Familia	0,35
Entorno	1
Total	5,35

MATERIALES Y RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN:

- Juegos de estimulación del desarrollo.
- Fichas de estimulación cognitiva.
- Material de psicomotricidad.
- Puzzles y rompecabezas.
- Lecturas relacionadas con las áreas de interés.
- Tareas para la ganancia de autonomía y funcionalidad.
- Escalas de desarrollo.
- Pictogramas.
- Material visual para apoyo al lenguaje.

FIRMAS:

Queremos destacar la importancia de que todos los agentes que están involucrados en el desarrollo del niño estemos coordinados y trabajemos en el mismo sentido, para así favorecer y multiplicar sus oportunidades de aprendizaje, de forma que aumenten sus posibilidades de evolución.

Fecha de la firma: 11 de Noviembre de 2025

Firmas de la familia

He recibido una copia de este documento, se me ha explicado y he entendido la información que contiene:

SI

NO

He participado como miembro de pleno derecho del equipo de desarrollo del PIAT:

SI

NO

Como miembro de pleno derecho del equipo de intervención y como padre/madre, tutor y/o educador del menor y por tanto principal protagonista, receptor y responsable de intervención, estoy de acuerdo con este documento:

SI

NO

Firma de los profesionales responsables del PIAT:

ANDREA PANEPINTO

LOGOPEDA

29/2280

